

CIÊNCIA QUE ESCUTA, SOLUÇÕES QUE TRANSFORMAM



APOSTILA

Gestão de riscos ocupacionais na prática

NR-1, GRO, PGR, NR-17 e fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Material didático para profissionais não especialistas em SST.

Autoria: Dra. Ana Paula Teixeira · Edição 2026

NR-1 · NR-17

GRO · PGR

FATORES PSICOSSOCIAIS

AVISO DE USO

Material educacional. Os modelos devem ser adaptados à atividade, ao porte, ao grau de risco, às Normas Regulamentadoras aplicáveis e às características reais da organização. A utilização dos modelos não substitui avaliação técnica competente.

• Apresentação

Esta apostila foi desenvolvida para profissionais que precisam participar da gestão de riscos ocupacionais, ainda que não tenham formação prévia em legislação de Saúde e Segurança no Trabalho (SST). O objetivo é fornecer uma visão prática para reconhecer perigos e fatores de risco, compreender exposições, avaliar probabilidade e severidade, analisar documentos essenciais e acompanhar a implementação das medidas de prevenção.

A abordagem parte de uma ideia central: gerenciar riscos não é apenas produzir documentos. É compreender o trabalho real, tomar decisões preventivas, registrar responsabilidades, executar medidas e verificar se elas funcionaram.

MENSAGEM CENTRAL

A empresa pode contratar profissionais e consultorias para apoiar a avaliação, mas permanece responsável por implementar e acompanhar a prevenção.

Objetivos de aprendizagem

- Compreender a lógica básica das Normas Regulamentadoras e da gestão de SST.

- Diferenciar perigo, fator de risco, exposição, dano, probabilidade, severidade e nível de risco.
- Reconhecer os principais grupos de riscos ocupacionais, incluindo fatores ergonômicos e psicossociais.
- Compreender a relação entre GRO, PGR, inventário de riscos e plano de ação.
- Analisar minimamente um PGR e identificar lacunas relevantes.
- Entender o papel da AEP, da AET, do PCMSO e dos registros complementares.
- Participar da priorização, implantação e monitoramento das medidas de prevenção.

SUMÁRIO

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Fundamentos da SST | 10. Grupo Homogêneo de Exposição |
| 2. Conceitos essenciais | 11. Integração com outros documentos |
| 3. Grupos de riscos ocupacionais | 12. Gestão dos fatores psicossociais |
| 4. O que mudou com a NR-1 | 13. Quando revisar a avaliação |
| 5. GRO e PGR | 14. Papéis e responsabilidades |
| 6. Reconhecer riscos no trabalho real | 15. Checklist para analisar um PGR |
| 7. Probabilidade e severidade | 16. Estudo de caso |
| 8. Hierarquia das medidas | 17. Síntese final |
| 9. NR-17, AEP e AET | Anexos — modelos e instrumentos |

01 Fundamentos da Saúde e Segurança no Trabalho

1.1 Por que existe a legislação de SST?

As Normas Regulamentadoras complementam a legislação trabalhista e estabelecem obrigações, direitos e deveres voltados à prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Seu propósito é assegurar ambientes e condições de trabalho seguros e saudáveis.

- Prevenir acidentes, doenças e agravos relacionados ao trabalho.
- Proteger a integridade física e mental dos trabalhadores.
- Definir responsabilidades organizacionais e requisitos mínimos de prevenção.
- Organizar evidências de que os riscos foram reconhecidos, avaliados e controlados.

1.2 O que o profissional não especialista precisa saber

- Reconhecer sinais de perigo e situações de exposição.
- Saber descrever o problema sem depender de diagnóstico médico.
- Identificar quem realiza a atividade e quem pode estar exposto.
- Solicitar avaliação técnica quando a complexidade ultrapassar sua competência.
- Acompanhar prazos, responsáveis, indicadores e evidências.
- Distinguir ações sobre a causa do risco de ações voltadas apenas ao indivíduo.

REGRA PRÁTICA

O profissional não precisa executar sozinho todas as avaliações. Precisa saber o que observar, o que perguntar, quando pedir apoio técnico e como verificar se a gestão está acontecendo.

02 Conceitos essenciais

CONCEITO	DEFINIÇÃO PRÁTICA	EXEMPLO
Perigo ou fator de risco	Fonte, situação, condição ou elemento com potencial de causar lesão ou agravo.	Máquina sem proteção; ruído; produto químico; sobrecarga; assédio.
Exposição	Contato do trabalhador com o perigo ou fator de risco.	Trabalhar diariamente em área ruidosa ou sob pressão de tempo recorrente.
Dano ou consequência	Resultado possível da exposição.	Perda auditiva, intoxicação, lesão, exaustão ou sofrimento mental.
Probabilidade	Possibilidade de o dano ocorrer, considerando exposição e controles.	Exposição contínua com controles frágeis tende a elevar a probabilidade.
Severidade	Magnitude do dano razoavelmente previsível.	Desconforto reversível, afastamento, incapacidade permanente ou morte.
Risco ocupacional	Combinação da probabilidade de ocorrência com a severidade do dano.	Risco de queda com provável ocorrência e consequência grave.
Risco residual	Risco que permanece após a implementação dos controles.	Ruído reduzido, mas ainda presente após enclausuramento da fonte.

2.1 A sequência lógica da avaliação

- 1 Descrever a atividade e o contexto real de trabalho.
- 2 Identificar o perigo ou fator de risco.
- 3 Identificar os trabalhadores ou grupos expostos.
- 4 Descrever os possíveis danos.
- 5 Avaliar os controles existentes.
- 6 Estimar a probabilidade e a severidade.
- 7 Classificar o risco e definir prioridade.
- 8 Selecionar, implementar e monitorar medidas de prevenção.

03 Principais grupos de riscos ocupacionais

GRUPO	EXEMPLOS
Agentes físicos	Ruído, vibração, calor, frio, radiações, pressões anormais.
Agentes químicos	Poeiras, fumos, névoas, gases, vapores, líquidos e substâncias químicas.
Agentes biológicos	Vírus, bactérias, fungos, parasitas, materiais e resíduos contaminados.
Perigos de acidentes	Máquinas, quedas, eletricidade, incêndio, explosão, trânsito, ferramentas.
Fatores ergonômicos	Posturas, força, repetitividade, carga, mobiliário, exigências cognitivas e organização do trabalho.
Fatores psicossociais relacionados ao trabalho	Demandas, autonomia, apoio, relacionamentos, papel, mudanças, violência, assédio, jornadas e conteúdo emocional.

ATENÇÃO À TERMINOLOGIA

A formulação adequada é "fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho". Na NR-1, eles são considerados no âmbito das condições de trabalho da NR-17 e se articulam com a organização do trabalho.

04 O que mudou com a atualização da NR-1

A atualização do capítulo 1.5 da NR-1 tornou expressa a necessidade de considerar, no GRO, as condições de trabalho previstas na NR-17, incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. A redação entrou em vigor em 26/05/2026.

ASPECTO	PRÁTICA ANTERIOR FREQUENTE	DIREÇÃO APÓS A ATUALIZAÇÃO
Fatores psicossociais	Já deveriam ser considerados pela articulação entre NR-1 e NR-17, mas eram frequentemente omitidos.	Inclusão expressa no processo de identificação e avaliação dos riscos ocupacionais.
Organização do trabalho	Muitas vezes tratada isoladamente pela ergonomia ou pelo RH.	Deve ser integrada ao GRO, ao inventário e ao plano de ação.
Critérios de avaliação	Uso frequente de matrizes genéricas e pouco documentadas.	Critérios, ferramentas e níveis de risco devem ser definidos e documentados.
Participação dos trabalhadores	Frequentemente episódica.	Consulta e participação são elementos relevantes para compreender a atividade real.
Intervenção psicossocial	Predomínio de palestras, benefícios e apoio individual.	Prioridade para mudanças nas condições e na organização do trabalho.
Evidência de gestão	Documento ou pesquisa isolada.	Processo contínuo: identificar, avaliar, agir, acompanhar e revisar.

FORMULAÇÃO PRECISA

A atualização da NR-1 não "criou" os fatores psicossociais. Ela explicitou sua inclusão no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais e reforçou a integração com a NR-17.

05 GRO e PGR: processo e documentação

5.1 GRO

O GRO é o conjunto coordenado e contínuo de ações de prevenção. Ele inclui identificação de perigos, avaliação de riscos, planejamento, implementação de medidas, acompanhamento, comunicação e revisão.

5.2 PGR

O PGR é a forma organizada pela qual a empresa materializa e demonstra o GRO. Ele deve refletir a realidade de cada estabelecimento e articular-se com os demais documentos e programas de SST.

SÍNTESE

GRO é o processo de gestão. PGR é a estrutura documental e operacional que registra e orienta esse processo.

5.4 Conteúdo mínimo do inventário

- Caracterização dos processos, ambientes e atividades.
- Identificação dos perigos e fatores de risco.
- Descrição dos possíveis danos.
- Caracterização dos grupos expostos.
- Medidas de prevenção existentes.
- Exposição e dados de avaliações aplicáveis.
- Avaliação e classificação dos riscos.
- Critérios utilizados na avaliação.

5.5 Conteúdo esperado no plano de ação

- Risco ou situação a ser tratada.
- Medida de prevenção e nível de controle pretendido.
- Prioridade, responsável e prazo.
- Recursos e interfaces necessários.
- Indicadores e evidências de implantação.
- Critério para verificar a eficácia.
- Situação da ação e risco residual.

06 Como reconhecer riscos no trabalho real

6.1 Sete perguntas essenciais

- Qual trabalho está sendo realizado?
- Como a atividade acontece na prática?
- O que pode causar lesão ou agravo?
- Quem está exposto e em quais circunstâncias?
- Com que frequência, duração e intensidade ocorre a exposição?
- Quais controles já existem e são usados?
- Os controles reduzem efetivamente o risco?

6.2 Fontes de informação

Observação direta; escuta de trabalhadores e gestores; AEP, AET e avaliações ambientais; acidentes, incidentes e quase acidentes; afastamentos, queixas, absenteísmo e rotatividade; horas extras, metas, retrabalho e falhas de qualidade; denúncias, conflitos e registros de violência ou assédio; dados do PCMSO e indicadores coletivos de saúde; mudanças de processo, tecnologia, estrutura ou gestão.

6.3 Trabalho prescrito e trabalho real

Trabalho prescrito é o que procedimentos, normas e descrições de cargo determinam. Trabalho real é o modo como as pessoas efetivamente precisam agir para entregar o resultado diante de restrições, variabilidades, urgências, falhas, imprevistos e demandas concorrentes. A boa avaliação deve considerar ambos.

07 Avaliação de probabilidade e severidade

PROB.	CRITÉRIO	SEV.	CRITÉRIO
1 Rara	Exposição eventual; controles robustos.	1 Leve	Reversível, sem afastamento.
2 Improv.	Exposição limitada, controles eficazes.	2 Baixa	Atendimento simples ou afastamento curto.
3 Possível	Exposição regular ou controles parciais.	3 Moderada	Tratamento ou incapacidade temporária.
4 Provável	Recorrente, controles frágeis.	4 Grave	Incapacidade prolongada.
5 Quase certa	Contínua, sem controle efetivo.	5 Catastrófica	Morte ou incapacidade permanente.

Uma forma simples de classificação é multiplicar Probabilidade × Severidade — modelo didático, não matriz universal imposta pela NR-1.

PONTUAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	DIRETRIZ
1 a 4	Baixo	Manter controles e monitorar.
5 a 9	Moderado	Planejar melhorias e acompanhar.
10 a 16	Alto	Intervenção prioritária e prazo reduzido.
17 a 25	Crítico	Ação imediata ou interrupção da exposição.

CUIDADO

Não utilizar apenas médias organizacionais. Um risco crítico localizado pode desaparecer na média geral e permanecer sem controle.

08 Hierarquia das medidas de prevenção

- 1 Eliminar o perigo ou a fonte de exposição.
- 2 Substituir materiais, equipamentos ou processos.
- 3 Proteção coletiva e soluções de engenharia.
- 4 Modificar a organização do trabalho.

5 Medidas administrativas e procedimentos.

6 EPI, quando aplicável.

8.1 Exemplo físico

Ruído: substituir equipamento ruidoso; enclausurar a fonte; isolar a área; reduzir tempo de exposição; complementar com proteção auditiva e vigilância da saúde.

8.2 Exemplo psicossocial

Sobrecarga: rever metas, demanda, dimensionamento, prioridades e jornada; melhorar distribuição e autonomia; capacitar gestores. O apoio psicológico pode ser necessário, mas não substitui a correção da causa organizacional.

09 NR-17, AEP e AET

9.1 AEP

Avaliação inicial das situações de trabalho. Pode utilizar abordagens qualitativas, semiquantitativas, quantitativas ou combinações. Deve subsidiar medidas de prevenção e integrar-se ao PGR.

9.2 AET

Análise aprofundada, indicada quando é necessário compreender melhor a atividade, quando as medidas são insuficientes, há problemas persistentes ou acidentes sugerem relação com o trabalho.

9.3 Elementos da organização do trabalho

Normas de produção e critérios de desempenho; modo operatório e variabilidade; exigências de tempo e ritmo; conteúdo das tarefas e exigências cognitivas; autonomia, comunicação, cooperação e apoio; jornadas, pausas, turnos e recuperação; mudanças organizacionais e condições para adaptação.

9.4 FLUXO RECOMENDADO

Reconhecimento no GRO → AEP → registro no inventário → plano de ação → AET, quando necessária → implementação → avaliação da eficácia → revisão do risco residual.

10 Grupo Homogêneo de Exposição – GHE

GHE é um agrupamento de trabalhadores que apresentam padrão semelhante de exposição, considerando ambiente, processo, tarefas, agentes, frequência, duração e controles. É uma técnica útil para organizar avaliações e registros, mas não substitui a análise das diferenças reais entre atividades.

IMPORTANTE

A sigla GHE não é um documento mínimo nominalmente exigido pela NR-1. É uma metodologia de agrupamento que pode apoiar o inventário, o PCMSO, avaliações quantitativas e a gestão das exposições.

10.1 Critérios para formar um GHE

10.2 Quando não agrupar

- Mesmo processo ou ambiente de trabalho.
- Atividades e tarefas suficientemente semelhantes.
- Fontes e agentes de exposição comparáveis.
- Frequência, duração e intensidade semelhantes.
- Controles existentes comparáveis.
- Funções com tarefas muito diferentes no mesmo setor.
- Exposições ocasionais críticas restritas a parte do grupo.
- Jornadas, turnos ou locais com condições distintas.
- Atividades especiais, emergenciais ou de manutenção.
- Diferenças relevantes de organização do trabalho.

11 Integração com outros documentos e processos

DOCUMENTO/PROCESSO	FINALIDADE
PCMSO	Planejar o acompanhamento da saúde de acordo com os riscos identificados no PGR.
ASO	Registrar a avaliação ocupacional individual, sem substituir a gestão coletiva dos riscos.
AEP/AET	Avaliar condições ergonômicas e a organização do trabalho.
LTCAT	Subsidiar a caracterização previdenciária das exposições, quando aplicável.
CAT	Comunicar acidente ou doença relacionada ao trabalho nos casos cabíveis.
Laudos específicos	Avaliar agentes ou situações que exijam medição ou análise especializada.
Treinamentos	Demonstrar capacitação exigida e desenvolvimento de competências preventivas.
Inspeções e auditorias	Verificar condições, desvios e funcionamento dos controles.
Indicadores coletivos	Acompanhar tendências, danos, exposições e eficácia das medidas.

Nem todos os documentos se aplicam da mesma forma a todas as organizações. A necessidade depende da atividade, dos riscos, do enquadramento legal e das NRs específicas aplicáveis.

12 Gestão dos fatores de riscos psicossociais

12.1 Etapas recomendadas

ETAPA	PRINCIPAIS ENTREGAS
Preparação	Definir governança, escopo, grupos, comunicação, confidencialidade e métodos.
Identificação	Combinar observação, escuta, documentos, indicadores, entrevistas, grupos focais e instrumentos.
Avaliação	Analisar frequência, duração, intensidade, abrangência, danos e controles.
Priorização	Considerar gravidade, recorrência, grupos expostos, controles e dados de dano.
Intervenção	Atuar prioritariamente na organização e nas condições de trabalho.
Monitoramento	Acompanhar exposição, ações, indicadores e risco residual.
Revisão	Reavaliar diante de mudanças, ineficácia, acidentes, adoecimentos ou novos requisitos.

12.2 Níveis de intervenção

NÍVEL	EXEMPLOS
Primária — causas organizacionais	Metas, dimensionamento, processos, jornadas, autonomia, papéis, prevenção de assédio, gestão da mudança.
Secundária — recursos e capacidades	Desenvolvimento de lideranças, comunicação, espaços de diálogo, preparação para mudanças.
Terciária — assistência e reabilitação	Acolhimento, tratamento, encaminhamento, retorno ao trabalho e acompanhamento de casos.

12.3 Indicadores possíveis

Percentual de trabalhadores/GHEs com exposição elevada; horas extras, jornadas extensas e pausas não realizadas; absenteísmo, afastamentos e retorno ao trabalho; rotatividade e mobilidade interna; incidentes, acidentes, retrabalho e falhas de qualidade; conflitos, denúncias, assédio e violência; percepção de demanda, apoio, autonomia, papel, relacionamento e mudança; percentual de medidas implantadas e riscos reduzidos ou eliminados.

13 Quando revisar a avaliação de riscos

- Após implantação de medidas, para avaliar o risco residual.
- Quando ocorrerem mudanças em processos, instalações, tecnologias ou organização do trabalho.
- Quando medidas forem inadequadas ou insuficientes.
- Após acidentes, doenças ou evidências de dano relacionado ao trabalho.
- Quando houver alteração de requisitos legais.
- Quando informações do acompanhamento de saúde ou dos trabalhadores indicarem necessidade.
- Periodicamente, conforme o prazo e as condições previstos na NR-1.

14 Papéis e responsabilidades

ATOR	RESPONSABILIDADE CENTRAL
Alta direção	Definir compromisso, aprovar recursos e acompanhar riscos prioritários.
Gestores	Implantar controles no trabalho real e comunicar mudanças.
SST	Coordenar tecnicamente o GRO/PGR e integrar avaliações.
Medicina do trabalho	Articular vigilância da saúde, PCMSO, casos e indicadores coletivos.
Ergonomia	Avaliar situações de trabalho, organização e exigências da atividade.
RH/Gestão de Pessoas	Apoiar políticas, liderança, organização, mudanças e indicadores.
CIPA e trabalhadores	Contribuir com conhecimento do trabalho real e acompanhar medidas.
Consultorias	Apoiar tecnicamente sem substituir a responsabilidade da organização.

15 Checklist para analisar um PGR

DIMENSÃO	PERGUNTA DE VERIFICAÇÃO
Estrutura	A empresa, os estabelecimentos, processos, setores, funções e atividades estão identificados?
Trabalho real	A avaliação considerou como a atividade realmente acontece?
Perigos e fatores	Os riscos físicos, químicos, biológicos, de acidentes, ergonômicos e psicossociais foram considerados?
Expostos	Os grupos e circunstâncias de exposição estão descritos?
Danos	Há relação coerente entre fator de risco e possíveis lesões ou agravos?
Critérios	Probabilidade, severidade e classificação possuem critérios documentados?
Controles	As medidas existentes foram avaliadas quanto à eficácia?
Plano de ação	Existem prioridade, responsável, prazo, indicador e evidência?
Hierarquia	As medidas atuam prioritariamente na fonte e na organização do trabalho?
Integração	PGR, PCMSO, AEP/AET, indicadores e processos de mudança estão articulados?
Participação	Os trabalhadores foram ouvidos e envolvidos?
Revisão	Há rotina para verificar eficácia e risco residual?

16 Estudo de caso para aplicação

Uma central de atendimento possui 30 trabalhadores. Há metas diárias elevadas, monitoramento permanente, baixa autonomia, clientes agressivos, pausas frequentemente adiadas, elevada rotatividade, aumento de afastamentos e cobranças por mensagens fora do horário.

Tarefa do grupo

- Identificar perigos e fatores de risco, e os grupos expostos.
- Descrever possíveis danos e avaliar controles existentes.
- Estimar probabilidade e severidade; classificar e priorizar.
- Propor medidas conforme a hierarquia de prevenção.
- Definir indicadores e evidências; preencher uma linha do inventário e do plano de ação.

PONTO DE DISCUSSÃO

A oferta de atendimento psicológico pode integrar a assistência, mas não controla metas excessivas, pausas suprimidas, baixa autonomia, violência externa ou cobrança fora da jornada.

17 Síntese final

A boa gestão de riscos integra conhecimento técnico, participação dos trabalhadores, responsabilidade gerencial e acompanhamento contínuo. O documento deve ser consequência de uma avaliação real, e não uma peça produzida apenas para arquivo.

QUATRO VERBOS DA GESTÃO

RECONHECER o que pode causar dano. AVALIAR probabilidade e severidade. CONTROLAR as causas e exposições. MONITORAR a eficácia e o risco residual.

• Referências normativas e técnicas essenciais

Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego. *Norma Regulamentadora nº 1 – Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais*. Redação vigente em 2026.

Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego. *Portaria MTE nº 1.419, de 27 de agosto de 2024*. Aprova nova redação do capítulo 1.5 da NR-1.

Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego. *Manual de interpretação e aplicação do capítulo 1.5 da NR-1: Gerenciamento de Riscos Ocupacionais*. 2026.

Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego. *Norma Regulamentadora nº 17 – Ergonomia*.

Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego. *Programa de Gerenciamento de Riscos – orientações institucionais*.

Consulta recomendada: portal oficial do Ministério do Trabalho e Emprego, seção Segurança e Saúde no Trabalho e Normas Regulamentadoras. A legislação deve ser verificada novamente antes da aplicação profissional, pois pode sofrer alterações.

ANEXOS

Modelos e instrumentos de apoio

Os anexos a seguir são modelos educacionais e editáveis. Devem ser adaptados à realidade, aos riscos, aos critérios da organização e às exigências das NRs específicas aplicáveis.

A1 Lista orientativa de perigos, fatores de risco e danos

GRUPO	PERIGO/FATOR	FONTES OU SITUAÇÕES	DANOS POSSÍVEIS
Físico	Ruído	Máquinas, ferramentas, veículos, compressores.	Perda auditiva, estresse fisiológico, falhas de comunicação.
Físico	Vibração	Ferramentas manuais, veículos, equipamentos móveis.	Distúrbios vasculares, neurológicos e musculoesqueléticos.
Químico	Poeiras e fumos	Mineração, corte, soldagem, combustão.	Doenças respiratórias, intoxicações, câncer conforme agente.
Biológico	Vírus e bactérias	Saúde, limpeza, resíduos, atendimento ao público.	Infecções e doenças transmissíveis.
Acidente	Queda de altura	Escadas, plataformas, telhados.	Fraturas, trauma grave, morte.
Acidente	Eletricidade	Instalações, painéis, manutenção.	Choque, queimadura, morte.
Ergonômico	Postura e força	Trabalho em pé, inclinações, carga manual.	Dor, fadiga, distúrbios musculoesqueléticos.
Ergonômico	Repetitividade	Linha, digitação, embalagem.	LER/DORT, fadiga localizada.
Psicossocial	Demanda excessiva	Metas incompatíveis, volume, urgência, falta de recursos.	Exaustão, sono prejudicado, conflitos e adoecimento.
Psicossocial	Baixa autonomia	Controle excessivo, pouca influência no método e nas pausas.	Desengajamento, tensão, sofrimento mental.
Psicossocial	Relacionamentos adversos	Conflitos, assédio, discriminação, retaliação.	Medo, silêncio, adoecimento, desligamento.
Psicossocial	Mudança mal gerida	Informação tardia, ausência de consulta e suporte.	Insegurança, resistência, sobrecarga, perda de confiança.
Psicossocial	Violência externa	Agressões de clientes, público ou comunidade.	Trauma, medo, sofrimento e afastamentos.

A2-A4 Modelo e exemplos de GHE

O Anexo 2 traz o modelo em branco (colunas: código, estabelecimento/setor, processo, cargos, atividades, ambiente/jornada, agentes/fatores, fontes, frequência/duração, controles existentes, observações). Os Anexos 3 e 4 exemplificam seu preenchimento:

CÓDIGO	SETOR	ATIVIDADES	FATORES ERGONÔMICOS / PSICOSSOCIAIS	EXPOSIÇÃO	APROFUNDAMENTO
GHE-ADM-01	Financeiro	Análise de documentos, lançamentos e fechamento mensal	Postura estática; repetitividade; picos de demanda no fechamento; baixa autonomia sobre prazos; interrupções frequentes	Diária; maior intensidade nos 5 últimos dias úteis	AEP e análise de demanda; AET se medidas forem insuficientes
GHE-ATD-01	Atendimento	Atendimento telefônico e digital a clientes	Postura sentada; atenção sustentada; metas elevadas; monitoramento; clientes agressivos; baixa autonomia; pausas adiadas	Contínua durante a jornada	AEP com escuta; avaliação psicossocial organizacional; AET

CRITÉRIO DE VALIDAÇÃO

Confirmar que os trabalhadores agrupados possuem exposição suficientemente semelhante. Registrar exceções e atividades especiais em GHE separado quando necessário.

A5-A7 AEP e AET – estrutura de registro

O Anexo 5 (AEP) e o Anexo 7 (ficha analítica da AET) organizam-se por dimensão observada – mobiliário e posto, posturas e força, exigências cognitivas, ritmo e metas, jornada e pausas, autonomia e relacionamentos, mudanças organizacionais, violência e eventos críticos – registrando, para cada uma: trabalhadores expostos, frequência/duração, danos possíveis, controles existentes, avaliação preliminar, medida recomendada e necessidade de AET. O Anexo 6 detalha o roteiro completo da AET:

SEÇÃO DA AET	CONTEÚDO MÍNIMO ORIENTATIVO
1. Identificação e demanda	Empresa, unidade, setor, situação analisada, solicitante, motivo e questão central.
5–6. Tarefa prescrita e atividade real	Procedimentos e padrões esperados vs. estratégias, regulações e imprevistos observados.
9. Organização e fatores psicossociais	Demanda, autonomia, apoio, papel, relacionamentos, justiça, mudança, violência, jornada e recuperação.
11. Diagnóstico ergonômico	Relações entre condições, atividade, exposição, danos e grupos envolvidos.
12–14. Recomendações, plano e eficácia	Medidas hierarquizadas, etapas de implementação, indicadores e reavaliação do risco residual.

ATENÇÃO

A AET não deve ser tratada como checklist burocrático. Seu valor está em analisar a atividade real, explicar as causas dos problemas e sustentar transformações viáveis.

A8-A9 Modelos em branco – inventário e plano de ação

O Anexo 8 (inventário) registra, por GHE: perigo/fator, fonte/situação, danos possíveis, exposição, controles, probabilidade, severidade, nível, prioridade, medidas requeridas e responsável. O Anexo 9 organiza o plano de ação:

ID	RISCO/SITUAÇÃO	PRIORIDADE	MEDIDA	RESPONSÁVEL/PRAZO	STATUS
[preencher]	[preencher]	[preencher]	[preencher]	[preencher]	[preencher]
[preencher]	[preencher]	[preencher]	[preencher]	[preencher]	[preencher]
[preencher]	[preencher]	[preencher]	[preencher]	[preencher]	[preencher]

A10 Exemplo preenchido de plano de ação do GRO

ID	RISCO/SITUAÇÃO	PRIORIDADE	MEDIDA	RESPONSÁVEL/PRAZO	STATUS / RESIDUAL
01	Sobrecarga no fechamento financeiro	Alto	Revisar calendário, critérios de prioridade, distribuição e capacidade da equipe	Diretoria Financeira + RH / 60 dias	Em andamento – residual a avaliar
02	Violência verbal e baixa autonomia no atendimento	Alto	Protocolo para clientes agressivos, autonomia para encerrar atendimento, pausas de recuperação e suporte imediato	Operações + SST / 45 dias	Planejado – residual a avaliar
03	Ruído de compressores	Crítico	Enclausurar fonte, revisar manutenção e restringir acesso até conclusão	Manutenção / 20 dias	Em andamento – médio provisório

A11 Checklist de gestão e acompanhamento

DIMENSÃO	PERGUNTA
Governança	Há responsável, participação da liderança e integração entre SST, saúde, RH e operação?
Escopo	Todos os estabelecimentos, processos, turnos, terceirizados e situações especiais foram considerados?
Participação	Os trabalhadores foram ouvidos com segurança e representatividade?
Avaliação	Os critérios são claros, coerentes e documentados?
Ação	As medidas tratam causas e seguem hierarquia de prevenção?
Evidências	Há registros verificáveis de implantação?
Eficácia	Indicadores demonstram redução da exposição ou do risco?
Revisão	O risco residual foi reavaliado e o inventário atualizado?

ENCERRAMENTO

Os modelos desta apostila foram construídos para apoiar aprendizagem, análise e organização da gestão. Uma empresa madura não mede sua conformidade apenas pela existência de documentos, mas pela capacidade de demonstrar que reconhece suas exposições, prioriza riscos relevantes, executa medidas e aprende com os resultados.

FRASE FINAL

O PGR deve contar a verdade sobre o trabalho, orientar decisões e produzir prevenção. Quando o documento não muda a realidade, o processo de gestão permanece incompleto.

ESCUTARIS

Ciência que escuta, soluções que transformam. Diagnóstico psicossocial, mentoria de liderança e consultoria em NR-1.

